PCMSO
BTRIL 02 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

HISTORICO DAS REVISÕES		
REVISÃO	**DATA**	**DESCRIÇÃO**
00	15/01/2025	Emissão

IDENTIFICAÇÃO

C.N.P.J:	**21.689.230/0001-80**
RAZÃO SOCIAL:	**BTRIL 02 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA**
ENDEREÇO:	**R NUNES VALENTE, Nº 2250, DIONISIO TORRES – FORTALEZA - CE**
ATIVIDADE PRINCIPAL:	**INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS**
C.N.A.E /GR	**41.10-7-00 - GR 02**
ATIVIDADE SECUNDÁRIA:	**CNAE / GR / ATIVIDADE** **41.20-4-00 - 02 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**
COLABORADORES:	20 COLABORADORES
JORNADA DE TRABALHO:	DAS 07:30 ÀS 17:30 – DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA; DAS 07:30 ÀS 16:30 – DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA COM 01 HORA DE INTERVALO PARA ALMOÇO
RESPONSÁVEL PELA EMPRESA:	

MÉDICO RESPONSÁVEL:	NILTON DA SILVA OLIVEIRA – CRM 19.934 MTE: 4307 ESP. RQE Nº 46462
E-MAIL:	slassessoriaemseguranca@gmail.com

ÍNDICE

1 Objetivo **04**

2 Campo de Aplicação **04**

3 Diretrizes **05**

4 Responsabilidades **05**

4.1 Médico Responsável pelo PCMSO **06**

5 Planejamento **06**

5.1 Caráter Ocupacional **06**

5.2 Caráter não Ocupacional **06**

5.3 Programa de Imunização **06**

5.4 Exames Médicos Ocupacionais **07**

5.5 Exames Médicos Complementares **07**

5.6 Atestado de Saúde Ocupacional **09**

6.0 Prontuários **10**

6.1 Relatório **10**

7. Tabela de Funções/Riscos/Exames/Periodicidade **11**

8. Cronograma de ações **12**

9. Encerramento **13**

Anexos **14-16**

NR O7 – PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL

Portaria MTb n.º 3.214, de 08 de junho de 1978 06/07/78

Alterações/Atualizações

Portaria SSMT n.º 12, de 06 de junho de 1983 14/06/83
Portaria MTPS n.º 3.720, de 31 de outubro de 1990 01/11/90 Portaria SSST n.º 24, de 29 de dezembro de 1994 30/12/90
Portaria SSST n.º 08, de 08 de maio de 1996 Rep. 09/05/96
Portaria SSST n.º 19, de 09 de abril de 1998 22/04/98
Portaria SIT n.º 223, de 06 de maio de 2011 10/05/11
Portaria SIT n.º 236, de 10 de junho de 2011 13/06/11
Portaria MTE n.º 1.892, de 09 de dezembro de 2013 11/12/13 Portaria MTb n.º 1.031, de 06 de dezembro de 2018 10/12/18
Portaria SEPRT n.º 6.734, de 09 de março de 2020 13/03/20 (Redação dada pela Portaria SEPRT n.º 6.734, de 10 de março de 2020) Vide prazo do art. 5º da referida Portaria – 1 ano após sua publicação.

1. OBJETIVO

Este PCMSO , tem como objetivo estabelecer diretrizes e requisitos para o desenvolvimento do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO nas organizações, com o objetivo de proteger e preservar a saúde de seus empregados em relação aos riscos ocupacionais, conforme avaliação de riscos do Programa de Gerenciamento de Risco - PGR da organização.

O **PCMSO** tem os seguintes objetivos:

1. Identificar situações de risco para o estado de saúde e bem-estar dos indivíduos e da coletividade de trabalhadores, privilegiando o instrumental clínico-epidemiológico na abordagem da relação entre sua saúde e o trabalho.

2. Assegurar que todos os trabalhadores sejam colocados em atividades de acordo com sua capacidade física e emocional, de modo a poder realizá-la sem perigo para si, seus colegas e sem danos à propriedade.

3. Prevenir, rastrear e diagnosticar precocemente os agravos à saúde relacionados ao trabalho, inclusive de natureza subclínica.

4. Detectar precocemente os casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Este PCMSO estabelece diretrizes e requisitos para o desenvolvimento do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO da empresa: **BTRIL 02 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA,** é parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas**,** no campo da saúde de seus empregados, devendo estar harmonizado com o disposto nas demais NR planejado e implantado com base nos riscos à saúde identificados qualitativamente e/ou quantitativamente, após prévio levantamento das exigências das atividades desempenhadas pelos trabalhadores tendo em vista que os processos de trabalho e o ambiente de trabalho podem vir a causar danos à saúde, é necessário estabelecer e implementar uma série de medidas referentes à avaliação dos riscos existentes, à promoção e manutenção do bem estar

físico, mental e social dos trabalhadores, à prevenção de doenças ocupacionais, à proteção dos trabalhadores contra os riscos resultantes de fatores adversos à saúde e à colocação e conservação dos trabalhadores no ambiente de trabalho adequado às suas aptidões físicas e psicológicas.

3. DIRETRIZES

Estas medidas são materializadas através do **PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL** (**PCMSO**) para todos os empregadores. Esta norma estabelece os parâmetros mínimos e as diretrizes gerais a serem observadas na execução do PCMSO, podendo as mesmas ser ampliadas mediante negociação coletiva de trabalho.

Implementação do PCMSO:

a) rastrear e detectar precocemente os agravos à saúde relacionados ao trabalho;
b) detectar possíveis exposições excessivas a agentes nocivos ocupacionais;
c) definir a aptidão de cada empregado para exercer suas funções ou tarefas determinadas;
d) subsidiar a implantação e o monitoramento da eficácia das medidas de prevenção adotadas na organização;
e) subsidiar análises epidemiológicas e estatísticas sobre os agravos à saúde e sua relação com os riscos ocupacionais;
f) subsidiar decisões sobre o afastamento de empregados de situações de trabalho que possam comprometer sua saúde;
g) subsidiar a emissão de notificações de agravos relacionados ao trabalho, de acordo com a regulamentação pertinente;
h) subsidiar o encaminhamento de empregados à Previdência Social;
i) acompanhar de forma diferenciada o empregado cujo estado de saúde possa ser especialmente afetado pelos riscos ocupacionais;
j) subsidiar a Previdência Social nas ações de reabilitação profissional;
k) subsidiar ações de readaptação profissional;
l) controlar da imunização ativa dos empregados, relacionada a riscos ocupacionais, sempre que houver recomendação do Ministério da Saúde

Ações do PCMSO:

- Vigilância passiva da saúde ocupacional, a partir de informações sobre a demanda espontânea de empregados que procurem serviços médicos
- Vigilância ativa da saúde ocupacional, por meio de exames médicos dirigidos que incluam, além dos exames previstos nesta NR, a coleta de dados sobre sinais e sintomas de agravos à saúde relacionados aos riscos ocupacionais.

O êxito do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional depende do estabelecimento de um sistema de parceria entre o serviço médico, a administração da empresa e seus trabalhadores desde que cada um, à sua maneira, tem um papel importante e específico na promoção, prevenção e proteção da saúde no ambiente de trabalho.

4. RESPONSABILIDADES

O controle médico terá como base critérios que irão compor um diagnóstico da empresa e de seus colaboradores, analisando todos os possíveis agravos à saúde do trabalhador. Desta forma será possível um estudo da ocorrência, distribuição e dos determinantes de um agravo, bem como a investigação de relações causais.

4.1 MÉDICO RESPONSÁVEL PELO PCMSO

MÉDICO	FUNÇÃO	CRM
	Médico Responsável - COODERNADOR	

5. PLANEJAMENTO

O PCMSO guarda forte relação com a nova NR 01 que instituiu o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. O PCMSO deve ser elaborado considerando os riscos ocupacionais identificados e classificados pelo PGR, ou seja, ele não deve conter riscos que não foram identificados previamente no PGR.

O médico responsável pelo PCMSO, caso observe inconsistências no inventário de riscos da organização, deve reavaliá-las em conjunto com os responsáveis pelo PGR No planejamento do seu PCMSO, a organização deve garantir que:

a) descreva os possíveis agravos à saúde relacionados aos riscos ocupacionais identificados e classificados no PGR;
b) contenha planejamento de exames médicos clínicos e complementares necessários, conforme os riscos ocupacionais identificados, atendendo ao determinado nos Anexos desta NR;
c) contenha os critérios de interpretação e planejamento das condutas relacionadas aos achados dos exames médicos;
d) seja conhecido e atendido por todos os médicos que realizarem os exames médicos ocupacionais dos empregados;
e) inclua relatório analítico sobre o desenvolvimento do programa.

5.1 DE CARÁTER OCUPACIONAL

Planejar e determinar as ações que deverão ser realizadas durante o período de vigência deste programa.

1. Programação anual dos exames ocupacionais (Realização dos exames clínicos, realização dos exames complementares direcionados para os riscos ambientais detectados)
2. Levantamento e reconhecimento dos riscos ambientais.
3. Levantamento e reconhecimento dos riscos ocupacionais.
4.

5.2 DE CARÁTER NÃO OCUPACIONAL

Serão desenvolvidas durante o período de vigência deste programa ações de saúde como programa de imunização, palestras educativas e campanhas, conforme os achados dos dados epidemiológicos da população em acompanhamento.

5.3 PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO

Conforme a Sociedade Brasileira de Imunização, são preconizadas para os trabalhadores as vacinas Dupla Adulto (3 doses) e Influenza (1 dose anual), que deverão ser administradas conforme o esquema a seguir:

Vacina Dupla Adulto

1ª dose no exame admissional ou no periódico, se não tiver sido aplicada no admissional.
2ª dose 2 meses após a primeira dose
3ª dose 4 meses após a primeira

Vacina contra Influenza

Dose única, anualmente.
Outras vacinas poderão ser administradas, de acordo com o local de trabalho, a idade do trabalhador ou a presença de doenças crônicas.

COVID 19

Ao apresentar sintomas, afastar imediatamente das atividades, procurar atendimento médico e realizar o teste para COVID 19.

5.4 EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS

O PCMSO deve incluir, entre outros, a realização obrigatória dos exames médicos:

TIPO DE EXAME	APLICAÇÃO	QUANDO REALIZAR
ADMISSIONAL	PARA TODOS OS COLABORADORES	ANTES QUE O EMPREGADO ASSUMA SUAS ATIVIDADES
PERIÓDICO	COLABORADORES EXPOSTOS A RISCOS IDENTIFICADOS NO PGR E PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS	ANUAL OU INTERVALOS MENORES A CRITÉRIO DO MÉDICO RESPONSÁVEL
	DEMAIS COLABORADORES	BIANUAL
RETORNO AO TRABALHO	TODOS OS COLABORADORES	O EXAME CLINICO DEVE SER REALIZADO ANTES QUE O COLABORADOR REASSUMA SUAS FUNÇÕES, QUANDO A AUSÊNCIA FOR IGUAL OU SUPERIOR A 30 DIAS (DOENÇA, ACIDENTES OCUPACIONAL OU NÃO. A AVALIAÇÃO MÉDICA DEVE DEFINIR A NECESSIDADE DE RETORNO GRADATIVO AO TRABALHO
MUDANÇA DE RISCO OCUPACIONAL (*)	TODOS OS COLABORADORES QUANDO HOUVER A MUDANÇA	O EXAME DEVE SER REALIZADO ANTES DA DATA DA MUDANÇA, ADEQUANDO O AOS NOVOS RISCOS
DEMISSIONAL	TODOS OS COLABORADORES	DEVE SER REALIZADO EM ATÉ 10 DIAS DO TÉRMINO DO CONTRATO DISPENSADO DO EXAME NOS SEGUINTES CASOS: ÚLTIMO EXAME REALIZADO FOR INFERIOR A 135 DIAS – EMPRESAS DE GRAU DE RISCO 1 E 2 ÚLTIMO EXAME REALIZADO FOR INFERIOR A 90 DIAS – EMPRESAS DE GRAU DE RISCO 3 E 4

*A realização do exame somente quando houver a alteração dos riscos aos quais possa Eventualmente, ele possa estar exposto.

5.5 EXAMES MÉDICOS COMPLEMENTARES

Os exames complementares laboratoriais previstos neste PCMSO são executados por laboratório aprovado pela RDC/Anvisa n.º 302/2005, no que se refere aos procedimentos de coleta, acondicionamento, transporte e análise, e interpretados com base nos critérios constantes nos Anexos desta Norma e são obrigatórios quando:

a) o levantamento preliminar do PGR indicar a necessidade de medidas de prevenção imediatas;
b) houver exposições ocupacionais acima dos níveis de ação determinados na NR-09 ou se a classificação de riscos do PGR indicar.

A aptidão para trabalho em atividades específicas, quando assim definido em Normas Regulamentadoras e seus Anexos, deve ser consignada no ASO. Quando forem realizados exames complementares sem que tenha ocorrido exame clínico, a organização emitirá recibo de entrega do resultado do exame, devendo o recibo ser fornecido ao empregado em meio físico, quando solicitado.

Sendo verificada a possibilidade de exposição excessiva a agentes listados no Quadro 1 do Anexo I da NR 07, o médico do trabalho responsável pelo PCMSO deve informar o fato aos responsáveis pelo PGR para reavaliação dos riscos ocupacionais e das medidas de prevenção.

Constatada ocorrência ou agravamento de doença relacionada ao trabalho ou alteração que revele disfunção orgânica por meio dos exames complementares do Quadro 2 do Anexo I, dos demais

Anexos desta NR ou dos exames complementares incluídos com base no subitem 7.5.18 da NR 07, caberáà organização, após informada pelo médico responsável pelo PCMSO:

a) emitir a Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT;
b) afastar o empregado da situação, ou do trabalho, quando necessário;
c) encaminhar o empregado à Previdência Social, quando houver afastamento do trabalho superior a 15 (quinze) dias, para avaliação de incapacidade e definição da conduta previdenciária; d) reavaliar os riscos ocupacionais e as medidas de prevenção pertinentes no PGR.

5.6 ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL

Para cada exame clínico ocupacional realizado, o médico emitirá Atestado de Saúde Ocupacional (ASO),que deve ser comprovadamente disponibilizado ao empregado, devendo ser fornecido em meio físico quando solicitado.

Devem constar do ASO:

a) razão social e CNPJ ou CAEPF da organização;
b) nome completo do empregado, o número de seu CPF e sua função;
c) a descrição dos perigos ou fatores de risco identificados e classificados no PGR que necessitem de controle médico previsto no PCMSO, ou a sua inexistência;
d) indicação e data de realização dos exames ocupacionais clínicos e complementares a que foi submetido o empregado;
e) definição de apto ou inapto para a função do empregado;
f) o nome e número de registro profissional do médico responsável pelo PCMSO, se houver; e, data, número de registro profissional e assinatura do médico que realizou o exame clínico. A aptidão para trabalho em atividades específicas, quando assim definido em Normas Regulamentadoras e seus Anexos, também deve ser consignada no ASO.

6.0 PRONTUÁRIOS

Os exames clínicos e complementares devem ser registrados em prontuário médico individual que deve ficar sob responsabilidade do médico responsável pelo PCMSO, ou do médico responsável pelo exame,

quando a empresa estiver dispensada de PCMSO.

Este prontuário deve ficar mantido pela empresa **BTRIL 02 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA**, pôr no mínimo 20 anos após o desligamento do empregado, exceto em previsão diferente constante dos anexos desta norma.
Em caso de substituição do médico responsável pelo PCMSO, a empresa deve garantir que os prontuários médicos sejam formalmente transferidos para seu sucessor. Os prontuários médicos podem ser utilizados em meio eletrônico desde que as exigências do Conselho Federal de Medicina sejam atendidas.

6.1 RELATÓRIO

A norma mantém a obrigatoriedade da elaboração anual de um relatório, considerando a data do último relatório elaborado, e passa a ser chamado de Relatório analítico. Este relatório deve conter, no mínimo:

a) o número de exames clínicos realizados;
b) o número e tipos de exames complementares realizados;
c) estatística de resultados anormais dos exames complementares, categorizados por tipo do exame e por unidade operacional, setor ou função;
d) incidência e prevalência de doenças relacionadas ao trabalho, categorizadas por unidade operacional, setor ou função;
e) informações sobre o número, tipo de eventos e doenças informadas nas CAT, emitidas pela organização, referentes a seus empregados;
f) análise comparativa em relação ao relatório anterior e discussão sobre as variações nos resultados.

O médico responsável pelo PCMSO, que também é o responsável pela elaboração do relatório analítico, deve considerar os dados dos prontuários médicos a ele transferidos e, caso não tenha recebido estes dados ou considere as informações insuficientes, este fato deve constar no relatório analítico. O relatório deve ser apresentado e discutido com os responsáveis por segurança e saúde no trabalho da organização, incluindo a CIPA , quando existente, para que as medidas de prevenção necessárias sejam adotadas na organização.

Fica estabelecido também que as organizações de graus de risco 1 e 2 com até 25 (vinte e cinco) empregados e as organizações de graus de risco 3 e 4 com até 10 (dez) podem elaborar o relatório analítico apenas com o número de exames clínicos realizados e o número de tipos de exames complementares realizados.

Material de primeiros socorros:

A NR 7 no capítulo 7.5.1 determina: 7.5.1 Todo estabelecimento deverá estar equipado com material necessário à prestação dos primeiros socorros, considerando-se as características da atividade desenvolvida; manter esse material guardado em local adequado e aos cuidados de pessoa treinada para esse fim.

COMPOSIÇÃO DO KIT DE PRIMEIROS SOCORROS	
Localização: Empreendimento	
ITEM	**QUANTIDADE**
Maleta padrão	01
Pacote de luva de procedimento	01
Pacote de Gases de Crepom esterilizados	02
Esparadrapo	01
Ataduras de Crepom	02
Caixa de Band-aid	01
Tesoura sem ponta	01
Soro fisiológico	01
Álcool em gel	01
Pacote de Algodão	01

7. TABELA FUNÇÃO/RISCOS/EXAMES/PERIODICIDADE

GHE	SETOR	FUNÇAO / CARGO	RISCOS	EXAMES	PERIODICIDADE
01	ADMINISTRATIVO	ENCARREGADO DE OBRAS ALMOXARIFE	**ERGONÔMICO**: POSIÇÃO DE TRABALHO MENTAL DE RACIOCINIO E CONCENTRAÇÃO **ERGONÔMICO**: POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS **ACIDENTE**: QUEDA DE MESMO NÍVEL	CLINICO	ADMISSIONAL, ANUAL E DEMISSIONAL
02	**OPERACIONAL**	CARPINTEIRO GUINCHEIRO PEDREIRO SERVENTE DE PEDREIRO OPERADOR DE BETONEIRA	**FÍSICO**: RUIDO **QUÍMICO**: INALAÇÃO DE POEIRAS **ERGONÔMICO**: POSTURA EM PÉ POR LONGOS PERÍODOS **ERGONÔMICO**: MOVIMENTOS REPETITIVOS **ERGONÔMICO**: LEVANTAMENTO DE PESO **ERGONÔMICO**: CONSTANTE DESLOCAMENTO A PÉ DURANTE A JORNADA DE TRABALHO **ACIDENTE:** QUEDA DE OBJETOS E/OU MATERIAIS **ACIDENTE:** OBJETOS PEFUROCORTANTES	CLINICO AUDIOMETRIA ESPIROMETRIA	ADMISSIONAL, ANUAL E DEMISSIONAL ADMISSIONAL, ANUAL E DEMISSIONAL ADMISSIONAL, ANUAL ADMISSIONAL, ANUAL ADMISSIONAL, ANUAL ADMISSIONAL, ANUAL ADMISSIONAL, ANUAL
02	**OPERACIONAL COMTRABALHOEM ALTURA**	PEDREIRO SERVENTE DE PEDREIRO	**ACIDENTE:** QUEDA EM ALTURA	CLINICO AUDIOMETRIA ACUIDADE VISUAL EEG ECG GLICEMIA HEMOGRAMA COMPLETO	Admissiomal/anual 0 * Só realizar exames caso for trabalhar em altura.

- NOS CASOS DE MUDANÇA DE RISCOS OCUPACIONAIS, DEVERÃO SER OBSERVADOS OS EXAMES INDICADOS NO QUADRO DO NOVO CARGO LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO ADIFERENÇA DAS EXPOSIÇÕES AOS RISCOS
- COMPARADOS AO CARGO ATUAL. EM CASOS DE DÚVIDAS CONSULTE O AUTOR/COORDENADOR DESTE DOCUMENTO = EXAME PERIÓDICO
- NO CASO DE RETORNO AO TRABALHO OS EXAMES DEVERÃO SER REALIZADOS ANTES QUE O FUNCIONÁRIO ASSUMA SUAS FUNÇÕES. = EXAME PERIÓDICO
- ENTENDE-SE RETORNO AO TRABALHO QUANDO AUSENTE POR PERÍODO IGUAL OU SUPERIOR A 30 DIAS
- NO EXAME DEMISSIONAL, O EXAME CLÍNICO DEVE SER REALIZADO EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS CONTADOS DO TÉRMINO DO CONTRATO, PODENDO SER DISPENSADO CASO O EXAME CLÍNICO OCUPACIONAL MAIS RECENTE TENHA SIDO REALIZADO HÁ MENOS DE 135 (CENTRO E TRINTA E CINCO) DIAS, PARA AS ORGANIZAÇÕES GRAUS DE RISCO 1 E 2,E HÁ MENOS DE 90 (NOVENTA) DIAS, PARA AS ORGANIZAÇÕES GRAUS DE RISCO

8. CRONOGRAMA DE AÇÕES DO PCMSO

PLANEJAMENTO ANUAL		MESES													
N.º	Medidas Preventivas	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	NOTAS	RESPONSÁVEL
01	Divulgação do PCMSO	x													GESTOR
02	Realização de exames periódicos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONFORME VENCIMENTO	GESTOR
03	Revisão do programa												x		MÉDICO RESPONSÁVEL
04	Campanhas Vacinação					X								VER CARTEIRA VACINAÇÃO	GESTOR
05	Palestras : DST / AIDS / Primeiros Socorros												X	PROGRAMAR DATA	TÉCNICO- ENFERMEIRO- MÉDICO
06	Palestras: Alcoolismo/ Tabagismo/ Drogas						X							PROGRAMAR DATA	TÉCNICO- ENFERMEIRO- MÉDICO
07	Monitoramento de casos crônicos													CASO A CASO	MÉDICO RESPONSÁVEL
X	**A SER REALIZADO (** O programa de treinamento acima estabelecido poderá sofrer alterações nas datas e temas descritos, de acordo com a necessidade identificada no período).														

Avaliação/monitoramento do programa

A avaliação/monitoramento do PCMSO é importante para acompanhar o cumprimento ou não, das metas estabelecidas (verificar no final do tempo estabelecido para a execução do programa). Além disso,pode ser realizado levando em consideração as observações feitas ao longo da execução do programa, o que poderá ocasionar correções ao longo do seu desenvolvimento.

9. ENCERRAMENTO

Este documento foi elaborado por **SL Assessoria** em **janeiro de 2025** contendo **16 páginas** rubricadas pelo profissional abaixo, em atendimento à **Portaria SEPRT n.º 6.734, de 09 de março de 2020 13/03/20 (Redação dada pela Portaria SEPRT n.º 6.734, de 10 de março de 2020) Videprazo do art. 5º da referida Portaria – 1,** podendo ser modificado sempre que constatado alteração deriscos à saúde do trabalhador, modificação do processo de trabalho, aquisição de novos equipamentos, identificação de riscos não identificados anteriormente, mudança na legislação procurando nortear as ações desenvolvidas pela **RCL COMERCIO, MANUTENCAO E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA,** no intuito de promover um ambiente de trabalho saudável a todos os seus colaboradores. A Medicina do Trabalho e a Engenharia de Segurançado Trabalho tem como objetivo primordial desenvolver ações de segurança e proteção ao trabalhador de forma que o mesmo não venha a adoecer ou se acidentar no exercício de suas atividades profissionaispromovendo um ambiente seguro por meio de conscientização da responsabilidade do empregador e empregado pela sua segurança individual e da coletividade.

Responsável Técnico: _____

Médico Responsável pelo PCMSO

Dr. Fernando Diógenes Teixeira – CRM 2900.

Médico do trabalho – RQE n° 10367

Responsável Pela Implantação:

_____

BTRIL 02 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

ANEXOS

1. Certificado de Habilitação profissional
2. Certificado do CRM da Empresa

ANEXOS 1 – CERTIFICADO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL – MÉDICO DO TRABALHO

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - CEARÁ
CÉDULA DE IDENTIDADE DE MÉDICO

NOME
FERNANDO DIÓGENES TEIXEIRA

CRM /UF
2900/CE

FILIAÇÃO
MARIA ELITA DIÓGENES TEIXEIRA
FRANCISCO JURACI TEIXEIRA

DATA DE INSCRIÇÃO
24/10/1979

VIA
02

ASSINATURA DO PORTADOR

CREMEC

CERTIFICADO

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO CEARÁ

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará, de acordo com a resolução vigente, certifica que registrou, em 23/09/2019, no livro nº 9, RQE nº 10367, folha nº 228, a qualificação do médico,
FERNANDO DIÓGENES TEIXEIRA, CRM nº 2900,

na especialidade de
MEDICINA DO TRABALHO

Com validade em todo o território nacional.

Fortaleza, 25 de setembro de 2019

HELVÉCIO NEVES FEITOSA
PRESIDENTE

ROGER MURILO RIBEIRO SOARES
1º SECRETÁRIO